

Datos Personales							
Nombre:	XIMENA SANDOVAL RUEDA	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2015-11-10	Edad	10 Años, 6 Meses, Y 2 Días
Identificación:	TI - 1067630399	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE-ENTRENA PATINAJE DE VELOCIDAD
Correo Electrónico:	Shirlyrueda87@gmail.Com - 1067630399			Dirección:	Manzana G Casa 6 Conjunto Cerrado Brasil		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		SHIRLY RUEDA - Parentesco (madre) - Teléfono (3043987953)					

Apertura psicología del 2026-05-12 02:08:26: 10 años, 6 meses, y 2 días

DATOS GENERALES

Remisión

Autorreferido (Particular)

DX principal

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 1

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

Refieren los padres “ella hace un deporte de patinaje de alto rendimiento porque compiten” “queremos fortalecer el proceso, que no se retire” “tiene mucho apego conmigo, estoy en el proceso de independizarla a otro cuarto” “se nos agota la paciencia porque es una niña muy activa” “le hablamos y no escucha, pareciera que se le estuviese hablando a la pared” “queremos fortalecer la aparte mental que no se dé por vencida fácilmente y que no necesite la aprobación de nosotros o de otras personas para avanzar”.

Enfermedad Actual

Acuden a consulta debido a dificultades observadas en los procesos de autonomía e independencia de la paciente. Los padres refieren que constantemente busca aprobación por parte de las figuras parentales para la realización de actividades cotidianas y toma de decisiones, evidenciándose alta necesidad de acompañamiento y dependencia emocional dentro del entorno familiar.
Refieren además dinámicas de sobreprotección parental, señalando que la menor ha permanecido acompañada de manera constante desde etapas tempranas del desarrollo, siendo la primera nieta de la familia. Mencionan que presenta dificultad para jugar sola y tolerar espacios de independencia, observándose apego significativo hacia las figuras de cuidado, especialmente hacia la madre y la hermana.
La familia informa que hace aproximadamente dos semanas iniciaron proceso de transición para favorecer mayor independencia al establecer habitación separada de los padres; sin embargo, la paciente manifiesta temor para dormir sola y dificultad para separarse de la madre durante la rutina nocturna, buscando constantemente contacto físico y cercanía con la hermana.
Adicionalmente, los padres reportan antecedentes recientes de conductas de mentira en aproximadamente tres situaciones durante el año anterior. Asimismo, manifiestan dificultad en la adherencia y motivación frente al entrenamiento previo relacionado con el patinaje, solicitando acompañamiento psicológico para fortalecer comprensión de la importancia de dichos procesos dentro de su formación deportiva y promover herramientas de autonomía, seguridad y regulación emocional.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico No Refiere	Tóxicos
Traumáticos Ninguno	Medicación No Refiere
Paraclínicos No Refiere	Hospitalizaciones No Refiere
Patología No Refiere	

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo 28 AÑOS	Enfermedades De La Madre No
Único Embarazo 1RO	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo No	Estado De La Madre Durante El Embarazo Tranquila

ANTECEDENTES	
Natales	
Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea Rompió Fuente
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 2700
Talla Al Nacer 51	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES	
Posnatales	
Hospitalizaciones Recién Nacido No Refiere	

ANTECEDENTES	
Desarrollo Psicomotor	
Control Cefálico 2M	Rolado 3M
Sedente Solo 4M	Gateo 8M
Bípedo Sin Ayuda 9M	Marcha 14M
Lenguaje Verbal 9M	Lenguaje Verbal Fluido 12M

ANTECEDENTES	
Médicos Familiares	
Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Hipertensión Diabetes	Otros Cáncer

Áreas de Ajuste y/o Desempeño	
Historia educativa Actualmente la paciente se encuentra escolarizada en el colegio San Fernando, cursando grado quinto de básica primaria. Según refiere la familia, presenta adecuado desempeño académico en las diferentes áreas escolares y buen proceso de adaptación al contexto educativo. Manifiesta interés y gusto por asignaturas como arte, educación física, inglés, matemáticas y ética. Asimismo, se describe como una estudiante participativa dentro del aula, con adecuada disposición hacia las actividades académicas y actitud colaborativa con sus compañeros. La familia refiere que mantiene buenas relaciones interpersonales dentro del entorno escolar, evidenciándose habilidades sociales funcionales y disposición para brindar apoyo a sus pares durante actividades académicas y grupales.	
Historia laboral No aplica	
Historia familiar Actualmente la paciente convive con el padre, el Sr. Fernando, de 41 años de edad; la madre, la Sra. Shirly, de 38 años; la hermana de 6 años y la abuela paterna, la Sra. Navas, de 67 años. La familia refiere mantener adecuados vínculos afectivos y dinámica familiar estable, caracterizada por buena relación entre sus integrantes y adecuada comunicación dentro del entorno	

familiar.

Historia social

La paciente es descrita como una niña sociable, con facilidad para establecer relaciones interpersonales e integrarse a diferentes contextos sociales. La familia refiere que presenta características de liderazgo, evidenciándose iniciativa y participación activa durante juegos, actividades grupales y espacios de interacción cotidiana. Asimismo, se observa adecuada adaptación social en las diferentes áreas de funcionamiento, mostrando tendencia a asumir roles de dirección o liderazgo dentro de actividades recreativas, escolares y deportivas.

Historia emocional/afectiva

La paciente es descrita por la familia como una niña cariñosa, afectuosa y expresiva emocionalmente dentro de sus relaciones interpersonales. Refieren adecuada capacidad para manifestar afecto y establecer vínculos cercanos con las personas significativas de su entorno. No obstante, actualmente se observan respuestas emocionales negativas ante diversas situaciones cotidianas, presentando baja tolerancia frente a circunstancias que le generan incomodidad o frustración, así como facilidad para alterarse emocionalmente ante determinados estímulos o demandas del entorno.

Historia deportiva

La paciente cuenta con aproximadamente tres años de participación en la práctica de patinaje recreativo, actividad que realiza de manera constante y complementa con entrenamiento funcional en gimnasio como parte de su acondicionamiento físico. Adicionalmente, manifiesta interés por el voleibol, disciplina que practica dentro del contexto escolar como actividad recreativa y de integración social.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

Se realiza proceso de evaluación psicológica inicial mediante entrevista semiestructurada con padres y paciente, observación directa en consulta y evaluación a través del juego, con el objetivo de explorar el perfil conductual, emocional y neurocognitivo de la menor.

Durante el proceso se evidenció adecuada disposición hacia las actividades propuestas, buena capacidad de interacción social y participación activa en tareas guiadas. Asimismo, se observaron características relacionadas con necesidad constante de aprobación, dificultad en procesos de autonomía y respuestas emocionales intensas ante determinadas situaciones cotidianas.

A nivel neurocognitivo, el perfil evaluado evidencia adecuado desempeño en las áreas de atención (90%), psicomotricidad (98,97%), función gnósica (100%), memoria (100%) y lenguaje (100%), observándose habilidades conservadas y acordes para su etapa del desarrollo. En el área de coeficiente de organización conductual (COB) se obtuvo un resultado de 92,31%, evidenciándose adecuada capacidad de adaptación conductual y funcionamiento general.

La evaluación permitió identificar recursos personales y sociales conservados, así como áreas de fortalecimiento relacionadas con autonomía emocional, manejo de frustración, regulación emocional y tolerancia progresiva a la separación de figuras significativas.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No refiere

Intervención neurológica

No refiere

Intervención neuropsicológica

No refiere

Otras intervenciones

No refiere

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

Se recibe a la paciente en adecuadas condiciones generales. Durante la valoración se muestra sonriente, amable y con adecuada disposición hacia el proceso terapéutico. Se encuentra alerta, consciente y orientada autopsíquica y alopsíquicamente. Presenta adecuada presentación personal, buen contacto visual y participación activa durante la entrevista y actividades propuestas. Impresiona con adecuado estado general de salud, facies tranquila y biotipo atlético. Se observa actitud abordable y colaboradora durante el proceso de evaluación. La memoria impresiona conservada, así como la capacidad de atención y comprensión durante la interacción clínica.

Lenguaje eulálico, coherente y organizado. Afecto eutímico, con adecuada modulación emocional durante la consulta. No se evidencian alteraciones sensorioceptivas ni manifestaciones compatibles con ideación suicida. Psicomotricidad conservada. Juicio y raciocinio acordes para la edad cronológica. Inteligencia impresiona en rango promedio. La paciente se muestra consciente y receptiva frente al proceso de acompañamiento psicológico.

Ciclos del Sueño

Conservados, duerme 8 horas.

Apetito

Conservado, le gusta la pasta boloñesa, la pizza, pollo, arroz, lentejas, plátano, huevo, chorizo, carne, chicharrón, tajada.

Actividades de Autocuidado

Indepiente con supervisión diaria

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

NREF - NO REFIERE

Impresión Diagnóstica Relacionada 1

NREF - NO REFIERE

Impresión Diagnóstica Relacionada 2

NREF - NO REFIERE

Establecido por primera vez

Si

Objeto de atención clínica

Dificultades en procesos de autonomía e independencia emocional. Rasgos de ansiedad ante separación de figuras de apego. Necesidad constante de aprobación externa. Baja tolerancia a la frustración y adaptación a límites.

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Fortalecer procesos de autonomía emocional e independencia funcional, promoviendo estrategias de regulación emocional, tolerancia a la frustración y adaptación progresiva a límites, cambios y separación de figuras de apego en los diferentes contextos de desarrollo de la paciente.

Objetivos Específicos

- Favorecer el desarrollo de autonomía progresiva en actividades cotidianas y espacios personales.
- Fortalecer herramientas emocionales para el manejo de ansiedad asociada a separación de figuras significativas.
- Promover mayor tolerancia a la frustración y adaptación ante límites y cambios de rutina.
- Fortalecer habilidades de seguridad personal y confianza en sí misma.
- Favorecer estrategias de regulación emocional frente a situaciones de incomodidad o exigencia.
- Promover adherencia y comprensión de procesos relacionados con el entrenamiento deportivo.
- Brindar orientación familiar frente a dinámicas de sobreprotección y fortalecimiento de autonomía infantil.

Sugerencias e Interconsultas

Orientación familiar: Con el objetivo de fortalecer estrategias de crianza orientadas a la autonomía, establecimiento de límites y disminución de dinámicas de sobreprotección.

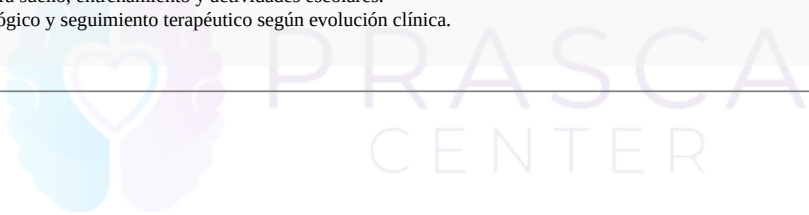
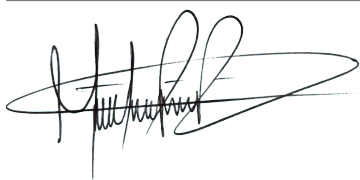
Observaciones y Recomendaciones

OBSERVACIONES:

Durante el proceso de valoración la paciente mostró adecuada disposición, participación activa y buena capacidad de interacción social. Se evidencian habilidades cognitivas conservadas, adecuado desempeño académico y recursos sociales funcionales. La familia presenta adecuada red de apoyo y compromiso frente al proceso terapéutico, identificándose interés en fortalecer herramientas emocionales y procesos de independencia progresiva.

RECOMENDACIONES:

- Favorecer progresivamente espacios de autonomía acordes a la edad de la paciente.
- Establecer límites claros y consistentes dentro del entorno familiar.
- Evitar reforzar conductas de dependencia emocional mediante sobreacompañamiento constante.
- Promover actividades individuales que fortalezcan seguridad y confianza personal.
- Validar las emociones de la paciente sin sobreproteger o anticiparse constantemente a sus necesidades.
- Favorecer rutinas estructuradas para sueño, entrenamiento y actividades escolares.
- Mantener acompañamiento psicológico y seguimiento terapéutico según evolución clínica.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU